

FRONT


care
 GROUP
 EDO CHAIN



PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Phakic)

Introduction

This patient information leaflet is designed to help you decide whether you want to have an Implantable Phakic Contact Lens (IPLC V2.0) placed in one or both eyes to correct your nearsightedness (myopia) or farsightedness (hyperopia). It is important to understand the benefits and possible risks before making your decision. Please read this leaflet carefully and discuss any questions with a doctor trained in IPLC V2.0 surgery.

What is Nearsightedness and Farsightedness?

NORMAL EYE

Light focuses on the retina.
 Vision is clear.

Normal Eye

NORMAL EYE:

Your eye works like a camera. You see objects because your eye focuses light into images. Both the clear front layer of your eye, called the cornea, and your natural crystalline lens focuses rays of light onto the back surface of the eye, called the retina.

NEARSIGHTED EYE

Light focuses in front of the retina. Vision is blurry.

Nearsighted Eye

NEARSIGHTED EYE:

Nearsightedness is a focusing error that causes blurrer vision at distance than at near. Light from an object in the distance focuses in front of the back surface of your eye (retina) responsible for capturing images, rather than directly on the retina.

FARSIGHTED EYE

Light focuses behind the retina. Vision is blurry.

Farsighted Eye

FARSIGHTED EYE:

Farsightedness (hyperopia) is a common vision condition in which you can see distant objects clearly, but objects nearby may be blurry.

Glasses and contact lenses can help your eye focus light properly on the retina. The IPLC V2.0 can also help your eye focus light properly on the retina.

How Does IPLC V2.0 Correct Nearsightedness and farsightedness?

CORRECTION OF VISION AFTER IPLC V2.0 SURGERY

Eye After Treatment

A diopter (D) is a unit to measure how well your eye can focus. It shows the level of nearsightedness, farsightedness, or astigmatism you have. IPLC V2.0 surgery can treat nearsightedness from +0.5 D to -15.0 D and farsightedness from +0.5 D to +15.0 D. If your vision falls within these ranges, this surgery may help you see clearly without glasses or contact lenses.

The IPLC V2.0 monofocal lens does not correct astigmatism. Astigmatism is a common vision problem that causes blurred or uneven vision. It happens when the front surface of the eye (cornea) is not evenly shaped. Because of this, light does not focus properly inside the eye, and some parts of what you see may look clearer than others.

NEARSIGHTED AND ASTIGMATIC EYE

Nearsighted and Astigmatic Eye

IPLC V2.0 Toric / IPLC V2.0 Presbyopic: Toric can correct any astigmatism you have up to +1.0 D to +10D. You are requested to consult your doctors to choose appropriate suitable options for your eyes.

Choosing the best lens for your vision

There are different types of lenses available. Your eye doctor will help you choose the one that is best for you. Other treatment options include glasses with thick lenses or contact lenses instead of a permanent lens implant. Talk to your eye doctor about the benefits and possible risks of each option.

Other Treatments to Correct Nearsightedness and Farsightedness ?

Other treatments to correct nearsightedness and farsightedness include eyeglasses, contact lenses, and refractive surgical procedures. Surgical options include Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser-Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), and phakic intraocular lens implantation (e.g., IPLC V2.0). However, these procedures may not meet the visual requirements for certain professions, such as military service.

These procedures either reshape the cornea or place a lens inside the eye. PRK and LASIK use a laser to reshape the shape of the cornea so the eye can focus better. In LASIK, a thin flap of the cornea is lifted, the laser reshapes the tissue underneath, and the flap is replaced in place. Phakic intraocular lens implantation, like IPLC V2.0, adds an artificial lens inside the eye without removing your natural lens.

Benefit And Risks of the IPLC V2.0

IPLC V2.0 surgery can safely correct nearsightedness between -0.50 to -15.0D and farsightedness between +0.50 to +15.0 D. If your eyeglasses prescription is in these ranges, the IPLC V2.0 may make your vision clearer without eyeglasses or contact lenses correction better.

Implanting IPLC V2.0 requires eye surgery, which carries potential risks. Please read this leaflet carefully and talk to your doctor about the possible risks.

■ Few of the risks are as below

■ Additional surgery
 Sometimes, a second surgery may be needed to remove, replace, or adjust the IPLC V2.0. It may need to be removed during cataracts surgery. Additional surgery might also be needed to reduce eye pressure.

■ Cataract formation
 After Phakic IOL surgery, there is an increased risk that the natural lens of your eye may become cloudy, leading to cataracts that could require surgery. The longer the IPLC V2.0 stays in the eye, the higher this risk becomes. Regular eye exams are important to check for cataracts. Older patients and those with stronger nearsightedness or farsightedness may have a higher risk. The long-term risk beyond 7 years is not known. If cataract surgery is needed, the IPLC V2.0 and the cloudy lens are removed, and a new lens is implanted, likely the modified cataract surgery.

■ Loss of Best Corrected Vision (BCVA)
 The most common reason was clouding of the natural lens (cataract). Vision may get better in these eyes after cataract surgery.

■ Raised pressure inside the eye and damage to the optical nerve caused by increased pressure in eye (Glaucoma)
 Normal eye pressure (intraocular pressure or IOP) can vary but is often considered to be from 10-21 millimeters of mercury (mmHg). An IOP higher than normal is called ocular hypertension or if left untreated, can cause damage to the optic nerve (glaucoma) and cause permanent vision loss.

■ Endothelial Cell Loss

Removal of the clear front part of your eye has a thin layer of special cells called endothelial cells. These cells keep the cornea clear by removing the excess fluid. Normally, the number of these cells slowly decreases with age. Eye surgery, including IPLC V2.0, can cause additional loss of these cells. If too many cells are lost, the cornea can become cloudy and affect your vision. Before surgery, your doctor will examine your eyes to check if you are suitable for IPLC V2.0. After the surgery, some ongoing loss of these cells may occur over time. If too many cells are lost, fluid can build up in the cornea (called corneal edema), which may require a cornea transplant.

■ Other Complications

Other risks associated with IPLC V2.0 surgery may include:
 ■ movement of the contact portion of the lens (iris) through a surgical wound to a position outside the eye (iris prolapse),
 ■ bleeding in the area or the natural response for reading vision (macular hemorrhage),
 ■ bleeding under the retina (subretinal hemorrhage),
 ■ increase in focusing error (astigmatism),
 ■ lifting or pulling of the retina from its natural position (retinal detachment), and
 ■ unequal pupil size (anisocoria).

Adverse reactions and complications due to, or following surgery and implantation of any implantable Phakic Contact Lens may include, but are not limited to:

- Increased astigmatism
- Refractive error
- Intraocular infection
- Vitreous loss
- Visual loss
- Anterior subcapsular cataract
- Severe intraocular inflammation
- Glaucoma
- Secondary glaucoma
- Uveitis
- Vitritis
- Hyphema
- Hyphema
- Hyphema</

[illegible][illegible]


care
GROUP

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Faccica)

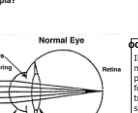
Introduzione:

Questo foglio informativo per il paziente è stato progettato per aiutarla a decidere se desidera l'impianto di una Lente a Contatto Faccica Implantabile (IPL V2.0) in uno o entrambi gli occhi per correggere la miopia e l'ipermetropia. È importante comprendere benefici e i possibili rischi prima di prendere una decisione. La invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discutere eventuali domande con un medico specializzato nella chirurgia IPL V2.0.

Chi cosa sono la miopia e l'ipermetropia?

OCCCHIO NORMALE

La luce si focalizza sulla retina. La visione è nitida.

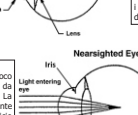


OCCCHIO NORMALE:

Il vostro occhio funziona come una macchina fotografica. Vedete gli oggetti perché l'occhio mette a fuoco la luce formando immagini. Se lo strato anteriore trasparente dell'occhio, chiamato cornea, sia il cristallino naturale focalizzano i raggi luminosi sulla superficie posteriore dell'occhio, chiamata retina.

OCCCHIO MIOPE:

La miopia è un difetto di messa a fuoco che provoca una vista più sfocata da lontano rispetto a quella da vicino. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata davanti alla superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.

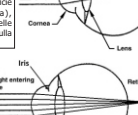


OCCCHIO MIPOPE

La luce si focalizza davanti alla retina. La visione è sfocata.

OCCCHIO IPERMETROPE

L'ipermetropia è un difetto di messa a fuoco che provoca una vista più sfocata da vicino rispetto a quella da lontano. La luce proveniente da un oggetto distante viene focalizzata dietro la superficie posteriore dell'occhio (retina), responsabile della formazione delle immagini, anziché direttamente sulla retina.



OCCCHIO IPERMETROPE:

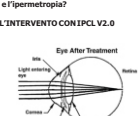
L'ipermetropia è un comune difetto visuale in cui è possibile vedere chiaramente gli oggetti lontani, mentre quelli vicini possono apparire sfocati.

Gli occhi e la lente a contatto possono aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina. Anche la IPL V2.0 può aiutare l'occhio a focalizzare correttamente la luce sulla retina.

Come corregge la IPL V2.0 la miopia e l'ipermetropia?

CORREZIONE DELLA VISIONE DOPO L'INTERVENTO CON IPL V2.0

Eye After Treatment

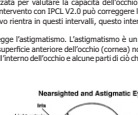


Sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista vi aiuterà a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesso e lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

La diottria (D) è un'unità di misura usata per valutare la capacità dell'occhio di mettere a fuoco. Indica il grado di miopia o ipermetropia assegnato prescrizione. L'intervento con IPL V2.0 può correggere la miopia da -0.5 D a +15.0 D e l'ipermetropia da +0.5 D a +5.0 D. Se il vostro oculista vi indica questi intervalli, questo intervento può aiutarvi a vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.

L'IPL V2.0 non corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo è un comune difetto visuale che provoca una visione sfocata o irregolare. Si verifica quando la superficie anteriore dell'occhio (cornea) non ha una forma uniforme. Per questo motivo, la luce non viene focalizzata correttamente all'interno dell'occhio e alcune parti di ciò che vedete possono apparire più nitide di altre.

OCCCHIO MIPOPE ASTIGMATICO



IPL V2.0 Torica / IPL V2.0 Presbiptica Torica può correggere l'astigmatismo da +1.0 D fino a +10.0 D. Invitiamo a consultare il vostro medico per scoprire l'opzione più appropriata e adatta ai vostri occhi.

Scegliate la lente migliore per la vostra vista

Altri trattamenti potrebbero includere lenti a contatto o lenti a scelta quotidiana a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesso e lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

Altri trattamenti per correggere miopia e l'ipermetropia?

Altri trattamenti potrebbero includere lenti a contatto o lenti a scelta quotidiana a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Altre opzioni di trattamento includono occhiali con lenti spesso e lenti a contatto in alternativa a un impianto permanente. Parlate con il vostro oculista dei benefici e dei possibili rischi di ciascuna opzione.

Queste procedure potrebbero non soddisfare i requisiti validi richiesti per alcune professioni, come il servizio militare.

Queste procedure modificherebbero la forma della cornea oppure prevedono l'inserimento di una lente all'interno dell'occhio. La PRK e la LASIK utilizzano un laser per modificare la forma della cornea al modo che l'occhio possa mettere a fuoco meglio. Nella LASIK, un cristallino correttore viene sollevato, il laser rimodella il tessuto sottostante e il tempo viene poi riposizionato affinché possa guarire l'incisione di una lente intraculare facica, come la IPL V2.0, aggiunge una lente artificiale all'interno dell'occhio senza rimuovere il cristallino naturale.

Benefici e rischi della IPL V2.0

L'intervento con IPL V2.0 può correggere in modo sicuro la miopia compresa tra -0.5 D e -15.0 D e l'ipermetropia compresa tra +0.5 D e +15.0. La vostra prescrizione per occhiali nitidi in questi intervalli, la IPL V2.0 può migliorare la vostra visione da lontano senza occhiali o lenti a contatto.

L'impianto della IPL V2.0 richiede un intervento chirurgico che comporta rischi specifici. Vi invitiamo a leggere attentamente questo foglio informativo e a discuterne con il vostro medico i possibili rischi.

*** Alcuni dei rischi sono riportati di seguito.**

- Intervento chirurgico aggiuntivo

In alcuni casi può essere necessario un secondo intervento per rimuovere, sostituire o regolare la IPL V2.0. Potrebbe essere necessario rimosso durante un intervento di cataratta. Un ulteriore intervento potrebbe anche essere richiesto per ridurre la pressione intraoculare.

- Formazione della cataratta

Dopo l'impianto di una IPL facica, esiste un rischio aumentato che il cristallino naturale dell'occhio diventi opaco, causando la cataratta. La parte anteriore trasparente dell'occhio (cornea), più a lungo la IPL V2.0 rimane nell'occhio, maggiore diventa questo rischio. Sono importanti controlli regolari per monitorare l'elevazione complessiva della cataratta. I pazienti più anziani e quelli che assumono farmaci per la pressione sanguigna hanno un rischio maggiore di sviluppare la cataratta. Se la cataratta è presente, si rende necessario un intervento di cataratta. La IPL V2.0 e il cristallino opacizzato vengono rimossi e viene impiantata una nuova lente, come avviene nella normale chirurgia della cataratta.

- Perdita della Migliore Acuità Visiva Correzibile (BCVA)

La causa più comune era l'opacizzazione del cristallino naturale (catartata). In questi occhi la vista può migliorare dopo l'intervento di cataratta.

- Aumento della pressione intraoculare e danno al nervo ottico causato da una pressione elevata nell'occhio (glaucoma)

A pressione normale dell'occhio (pressione intraoculare o IOP) può variare, ma è generalmente considerata compresa tra 10 e 21 millimetri di mercurio (mmHg). Una IOP superiore alla normale è definita ipertensione oculare, e se non trattata, può causare danni al nervo ottico (glaucoma) e portare a una perdita permanente della vista.

- Perdita delle Cellule Endoteliali

Le cellule endoteliali (parte interna dell'occhio) possiede un sottile strato di cellule specializzate chiamate cellule endoteliali. Queste cellule mantengono la cornea trasparente eliminando il liquido in eccesso. Normalmente, il numero di queste cellule diminuisce lentamente con l'età. La chirurgia oculare, compreso l'impianto della IPL V2.0, può causare una perdita aggiuntiva di tali cellule. Se vengono perse troppe cellule, la cornea può diventare opaca e compromettere la vista.

Prima dell'intervento, il medico esaminerà i vostri occhi per verificare se siete idonei all'impianto della IPL V2.0. Dopo l'intervento, può verificarsi nel tempo una continua perdita di queste cellule. Se la perdita è eccessiva, può accumularsi liquido nella cornea (edema coraleale), condizione che può richiedere un trapianto di cornea.

- Effetti Complicanze

Altri rischi associati alla chirurgia IPL V2.0 possono includere:

- spostamento della parte colorata dell'occhio (iride) attraverso una ferita chirurgica verso una posizione esterna all'occhio (prolasso dell'iride).
- sanguinamento nell'area della lente responsabile della visione per la lettura (emorragia maculare);
- sanguinamento sotto la retina (emorragia sottoretinica);
- aumento del difetto refrattivo (astigmatismo);
- sollevamento o trazione della retina dalla sua posizione naturale (distacco di retina);
- dimensioni non uguali delle pupille (anisocoria).

Le reazioni avverse e le complicanze dovute, o a successive all'intervento chirurgico o al impianto di qualsiasi Lente a Contatto Faccica possono includere, ma non sono limitate a:

- Aumento dell'astigmatismo
- Emorragia refrattiva
- Infestazione intraoculare
- Perdita di visione
- Problemi di visualità
- Cataratta anteposizionale anteriore
- Grave infiammazione intraoculare
- Glaucoma secondario
- Uveite
- Vitrite
- Blebs
- Sinechiae
- Sottocapsulazione/Sovracapsulazione
- Pupilla non reattiva
- Endofthalmitis
- TASS (Sindrome Trovato del Segmento Anteriore)
- Distacco di retina
- Irte
- Edema maculare cistioidale
- Edema maculare
- Compensazione coraleale
- Edema coraleale
- Ricono pupillare
- Catartata refrattiva
- Catartata d'aspetto
- IOP > 5 mmHg rispetto al valore basale e IOP > 25 mmHg

care
GROUP
CORPORATION

FOLHETO INFORMATIVO PARA O PACIENTE

Tipo de Dispositivo: Lente Intraocular (Fábrica)

Introdução
Este folheto informativo para o paciente foi concebido para o ajudar a decidir se pretende que seja implantada uma Lente de Contacto Fácica Implantável (PCL V2.0) num ou em ambos os olhos para corrigir a sua miopia (visão ao longe deficiente) ou hipermetropia (visão ao perto deficiente). É importante compreender os benefícios e os possíveis riscos antes de tomar a sua decisão. Leia atentamente este folheto e discuta quaisquer dúvidas com um médico treinado em cirurgia PCL V2.0.

O QUE é miopia e hipermetropia?

OLHO NORMAL
A luz é focada na retina.
A visão é nítida.

Normal Eye

A lente intraocular funciona como uma câmara fotográfica. Ví as coisas porque o seu olho foca a luz em imagens. Tanto a parte frontal transparente do olho, denominada córnea, como o seu cristallino natural focam os raios da luz na superfície posterior do olho, denominado retina.

OLHO MÍOPE
A luz é focada à frente da retina.
A visão é desfocada.

Myopic Eye

OLHO HIPERMÉTROPE
A hipermetropia é uma condição visual comum em que consegue ver claramente os objetos distantes, mas os objetos próximos podem parecer desfocados.

Hypertropic Eye

Os Óculos e as lentes de contacto ajudam você a olhar e a focar corretamente a luz na retina. A I.P.C.L.V2.0 também pode ajudá-lo a fazer isso sem óculos ou lentes de contato.

Como a I.P.C.L.V2.0 corrige a miopia e a hipermetropia?

CORREÇÃO DA VISÃO APÓS A CIRURGIA COM I.P.C.L.V2.0

A dioptria (D) é uma unidade utilizada para medir a capacidade de foco do olho. Indica o grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo que possui. A cirurgia com I.P.C.L.V2.0 pode tratar a miopia de +0.5 D a -15.0 D e a hipermetropia de +0.5 D a +15.0 D. Se os seus médicos permitirem que o olho fique melhor, esta cirurgia poderá ajudá-lo a ver claramente sem óculos ou lentes de contacto. A lente monofocal I.P.C.L.V2.0 não corrige o astigmatismo. O astigmatismo é um problema visual comum que provoca visão desfocada quando olha diretamente para a frente ou para cima. Quando o olho tem muita curvatura irregular (cerne), não tem uma forma esférica, a luz não é focalizada corretamente no interior do olho e algumas partes do quê vê podem parecer mais arredadas do que outras.

OLHO MÍOPE E ASTIGMÁTICO

Nearighted and Astigmatic Eye

A I.P.C.L.V2.0 Tórica / I.P.C.L.V2.0 Tórica Para Presbiopia pode corrigir qualquer astigmatismo entre +1.0 D e -10 D. Recomendamos que consulte aos seus médicos para escolher os seus meios adequados para o seu olho.

Ecoherer a melhor lente para os seus olhos
Existem diferentes tipos de lentes disponíveis. O seu oftalmologista ajudá-lo-á a escolher a que melhor se adequa a si. Outras opções de tratamento incluem óculos com lentes especiais e lentes de contacto em vez de um implante permanente. Fale com o seu oftalmologista sobre os benefícios e os possíveis riscos de cada opção.

Outros tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia
Quatro tratamentos para corrigir a miopia e a hipermetropia incluem óculos, lentes de contacto e procedimentos cirúrgicos refrativos. As opções cirúrgicas incluem a Ceratoplastia Fotorefrativa (PRK), a Ceratomilesia Assistida por Laser In Situ (LASIK), a troca refrativa do cristalino (RLR) e implantação de lentes intraoculares fáscas (por exemplo I.P.C.L.V2.0). Entanto, entretanto, estes procedimentos podem não satisfazer os requisitos visuais de determinadas profissões, como o serviço militar. Estes procedimentos remodelam a córnea ou colocam uma lente no interior do olho. A PRK e o LASIK utilizam um laser para alterar a corneia e melhorar a maneira que o olho foca melhor. No LASIK, é levantado um fino retalho da córnea, a laser remodela o tecido subjacente e o retalho é recolocado para a cicatrizar. A implantação de uma lente intraocular substitui uma lente nativa, tal como acontece numa cirurgia convencional de cataratas.

Benefícios e riscos da PCL V2.0
A cirurgia com I.P.C.L.V2.0 pode permitir que continue a seguir uma miopia entre -0.5 D e -15 D e a hipermetropia entre +0.5 D e +15 D. Se a sua graduação ocular se enquadrar nestes intervalos, a PCL V2.0 poderá melhor a sua visão ao longo sem necessidade de correção com óculos ou lentes de contacto.

Riscos potenciais:
A implantação da PCL V2.0 requer cirurgia ocular, a qual envolve riscos potenciais. Leia atentamente este folheto e converse com o seu médico sobre os seguintes riscos:

- Alguns dos riscos incluem:**
 - Cirurgia adicional
 - Formação de catarata
 - Após a cirurgia com LIO, existe um risco aumentado de o cristallino natural do olho se tornar opaco, levando ao desenvolvimento de cataratas que poderão necessitar de cirurgia. Quanto mais tempo a PCL V2.0 permanecer no olho, maior será o risco de desenvolver cataratas. Os sintomas comuns das cataratas incluem dificuldade para monitorizar o aparecimento de cataratas. Os pacientes mais idosos e aqueles com miopia ou hipermetropia mais acentuadas podem apresentar um risco elevado. Isto ocorre a longo prazo para pessoas com idade inferior a 60 anos. Depois de 10 anos após a cirurgia com LIO, há um aumento significativo do risco de desenvolver cataratas. Por conseguinte, recomendamos que se faça exames regulares para verificar se está a desenvolver cataratas e que considere a remoção de uma catarata adequada para a PCL V2.0. Após a cirurgia, poder ocorrer alguma perda definitiva dos tecidos ao longo do tempo. Se forem perdidas demasiadas células, poderá acumular-se líquido na córnea (denominação edema corneano), o que poderá exigir um transplante de córnea.
- Pêda da Melhor Acuidade Visual Corrigida (BCVA)**
A causa mais comum para a incapacitação do cristallino natural (catarrata). A visão pode melhorar nestes olhos após a cirurgia das cataratas.
 - Aumento da pressão intraocular e tensão do nervo ótico causada pelo aumento da pressão no olho (Glaucoma)
 - A pressão ocular normal (pressão intraocular ou PIO) pode variar, mas é geralmente considerada entre 10 e 21 milímetros de mercúrio (mmHg). Uma PIO superior ao normal é denominada hipertensão ocular e, se não for tratada, pode causar danos no nervo óptico (glaucoma) e provocar perda permanente da visão.
- Pêdas de células endoteliais**
 - Cómeja (a parte frontal transparente do olho) possui uma fina camada de células especiais denominadas células endoteliais. Estas células mantêm a córnea transparente removendo o excesso de fluido. Normalmente, o número destas células diminui gradualmente com a idade. A cirurgia com a PCL V2.0, pode causar uma perda adicional destas células. Se forem perdidas demasiadas células, a córnea pode tornar-se opaca e afetar a visão. Antes da cirurgia, o seu médico examinou os seus olhos para verificar se era um candidato adequado para a PCL V2.0. Após a cirurgia, poder ocorrer alguma perda definitiva dos tecidos ao longo do tempo. Se forem perdidas demasiadas células, poderá acumular-se líquido na córnea (denominação edema corneano), o que poderá exigir um transplante de córnea.
- Outras complicações**
Outros riscos associados à cirurgia com I.P.C.L.V2.0 incluem:
 - deslocação da parte colorada do olho (íris) através de uma ferida cirúrgica para uma posição fora do olho (prolapso da íris),
 - hemorragia na área da retina responsável pela visão de futuro ("hemorragia macular"),
 - hemorragia sob a retina (hemorragia pré-retiniana),
 - crescimento excessivo do tecido conjuntival (epitélio),
 - elevação ou tração da retina da sua posição natural (descolamento da retina),
 - tamanho desigual das pupilas (anisocoria).

As reações adversas e complicações decorrentes da cirurgia e da implantação de fáscas de Lente de Contacto Fácica Implantável são:

- Aumento do astigmatismo
- Ocu reflexivo
- Inflamação intraocular
- Perda de visão
- Problemas de vaulting
- Catarata subcapsular anterior
- Inflamação intraocular grave
- Glaucoma
- Graeca secundária
- Válvula
- Vitrite
- Hipópio
- Sobrecarga/insuficiência
- Dilatação da pupila
- Endoftálmite
- ASS
- Descolamento da retina
- Irie
- Edema macular difuso
- Edema macular
- Descascagem da epitélio
- Edema corneano
- Blepharite/palpebre
- Captura da íris
- PIO > 5 mmHg actua do valor basal e PIO > 25 mmHg





FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tipo de dispositivo: Lente Intracáular (Fábrica)

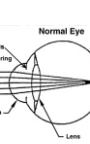
Introducción

Este folleto de información para el paciente está diseñado para ayudarle a decidir si desea que se le implante una Lente de Contacto Fábrica Implantable (PCL V2.0) en uno o ambos ojos para corregir su miopía o hipermetropía. Es importante comprender los beneficios y los posibles riesgos antes de tomar su decisión. Lea atentamente este folleto y consulte cualquier duda con un médico capacitado en cirugía PCL V2.0.

¿Qué son la miopía y la hipermetropía?

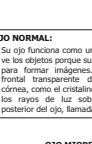
OJO NORMAL

La luz se enfoca en la retina. La visión es nítida.



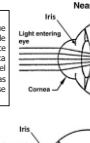
OJO NORMAL

Su ojo funciona como una cámara. Usted ve los objetos porque su ojo enfoca la luz para formar imágenes. Tanto la cámara frontal transparente del ojo, llamada córnea, como el cristalino natural enfocan los rayos de luz sobre la superficie posterior del ojo, llamada retina.



OJO MIOPE

La luz se enfoca delante de la retina. La visión es borrosa.



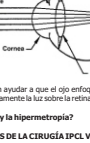
OJO MIOPE

La hipermetropía es una afección visual común en la que puede ver claramente los objetos lejanos, pero los objetos cercanos pueden verse borrosos.



OJO HIPERMETROPE

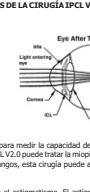
La hipermetropía es una afección visual común en la que puede ver claramente los objetos lejanos, pero los objetos cercanos pueden verse borrosos.



Las gafas y las lentes de contacto pueden ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina. La PCL V2.0 también puede ayudar a que el ojo enfoque correctamente la luz sobre la retina.

¿Cómo corrige la PCL V2.0 la miopía y la hipermetropía?

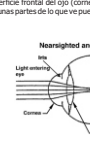
CORRECCIÓN DE LA VISIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA PCL V2.0



Una dioptría (D) es una unidad utilizada para medir la capacidad de enfoque del ojo. Indica el grado de miopía, hipermetropía o astigmatismo que presenta. La cirugía PCL V2.0 puede tratar la miopía de +0.5 D a +15.0 D y la hipermetropía de +0.5 D a +15.0 D. Si su visión es peor que la de estos rangos, esta cirugía puede ayudarle a ver con claridad sin necesidad de gafas o lentes de contacto.

La lente monocular PCL V2.0 no corrige el astigmatismo. El astigmatismo es un problema visual frecuente que provoca visión borrosa o irregular. Ocurre cuando la superficie frontal del ojo (córnea) no tiene una forma uniforme. Como resultado, la luz no se enfoca correctamente dentro del ojo o algunas partes de lo que ve pueden parecer más claras que otras.

OJO MIOPE ASTIGMÁTICO



PCL V2.0 Tónica / PCL V2.0 Tónica para Presbicia pueden corregir el astigmatismo que presente desde +1,0 D hasta +10,0 D. Si le interesa más consultar con un especialista en cirugía refractiva.

Cómo elegir la mejor lente para su visión

Existen diferentes tipos de lentes disponibles. Su oftalmólogo le ayudará a elegir la que mejor se adapte a usted. Otras opciones de tratamiento incluyen gafas con lentes gruesas o lentes de contacto en lugar de un implante permanente. Nable con su oftalmólogo sobre los beneficios y los posibles riesgos de cada opción.

¿Qué otros tratamientos existen para corregir la miopía y la hipermetropía?

Otros tratamientos para corregir la miopía y la hipermetropía incluyen gafas, lentes de contacto y procedimientos quirúrgicos refractivos. Las opciones quirúrgicas incluyen la queratomilesia fotorrefractiva (PRK), la queratomilesia in situ asistida por láser (LASIK), el intercambio de cristalino refractivo (ICR) o la implantación de lentes intracáculares fábricas (por ejemplo, PCL V2.0). Si embargo, estos procedimientos pueden no cumplir con los requisitos visuales de determinadas profesiones, como el servicio militar.

Estos procedimientos remodelan la córnea o colocan una lente dentro del ojo. La PRK y el LASIK utilizan un láser para modificar la forma de la córnea y mejorar el enfoque del ojo. En el LASIK, se levanta una fina lámina de la córnea, el láser remodela el tejido subyacente y posteriormente la lámina se reemplaza en su lugar que cicatriza. La implantación de una lente intracáular fábrica, como la PCL V2.0, alivia la carga de la lente dentro del ojo sin retirar el cristalino natural.

Beneficios y riesgos de la PCL V2.0

La cirugía PCL V2.0 puede corregir la miopía entre -0.5 D y +15.0 D, y la hipermetropía entre +0.5 D y +15.0 D. Si su graduación se encuentra dentro de estos rangos, la PCL V2.0 puede corregir su visión lejana sin necesidad de gafas o lentes de contacto. La implantación de la PCL V2.0 requiere cirugía ocular, la cual conlleva riesgos potenciales. Lea atentamente este folleto y consulte con un médico sobre los posibles riesgos.

- Algunos de los riesgos son los siguientes:
 - Cirugía adicional

En ocasiones puede ser necesaria una segunda intervención quirúrgica para retirar, reemplazar o ajustar la PCL V2.0. Puede ser necesario retirarla durante una cirugía de cataratas. También puede requerirse una cirugía adicional para reducir la presión ocular.

- Formación de cataratas

Después de la cirugía con una lente intracáular fábrica, existe un mayor riesgo de que el cristalino natural del ojo se vuelva opaco provocando cataratas que podrían requerir cirugía. Cuando más tiempo permanezca la PCL V2.0 dentro del ojo, mayor será el riesgo de que se desarrollen cataratas. Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar cataratas. Los pacientes con diabetes que tienen cataratas leves o moderadas pueden necesitar una cirugía de cataratas. Si se requiere cirugía de cataratas, se retirará tanto la PCL V2.0 como el cristalino opaco, y se implantará una nueva lente, de forma similar a una cirugía de cataratas convencional.

- Perdida de la Mejor Agudeza Visual Corregida (BCVA)

La causa más frecuente fue la opacificación del cristalino natural (catarata). La visión puede mejorar en estos ojos después de la cirugía de cataratas.

- Aumento de la presión dentro del ojo o daño al nervio óptico causado por el incremento de la presión ocular (Glaucoma)

La presión ocular (presión intraocular o PIO) puede variar; pero generalmente se considera que se encuentra entre 10 y 21 milímetros de mercurio (mmHg). Una PIO superior a la normal se denomina hipertensión ocular, y si no se trata, puede causar daño al nervio óptico (glaucoma) y provocar una pérdida permanente de la visión.

- Perdida de células endoteliales

Conforme a la cirugía PCL V2.0, el ojo posee una fina capa de células especiales llamadas células endoteliales. Estas células mantienen la cámara posterior eliminando el exceso de líquido. Normalmente, el número de estas células disminuye lentamente con la edad, pero la cirugía ocular, incluida la PCL V2.0, puede causar una pérdida adicional de estas células. Si se pierden demasiadas células, la córnea puede volverse opaca y afectar a su visión.

Antes de la cirugía, su médico examinará sus ojos para comprobar si es un candidato adecuado para la PCL V2.0. Después de la cirugía, puede producirse una pérdida continua de estas células con el paso del tiempo. Si se pierden demasiadas células, puede acumularse líquido en la cámara (denominado edema macular), lo que podría requerir un trasplante de células.

Otros complicaciones

Otros riesgos asociados con la cirugía PCL V2.0 pueden incluir:

- desplazamiento de la parte coloreada del ojo (iris) a través de una herida quirúrgica hacia una posición fuera del ojo (prolapso del iris);
- hemorragia en el área de la retina responsable de la visión de lectura (hemorragia macular);
- hemorragia debajo de la retina (hemorragia subretiniana);
- aumento del error de enfoque (astigmatismo);
- desprendimiento o tracción de la retina desde su posición natural (desprendimiento de retina);
- maltrato/desgaro de las pupilas (anterior);

Las molestias después y complicaciones debidas a la cirugía o posteriores a ella, así como a la implantación de cualquier Lente de Contacto Fábrica, pueden incluir, pero no se limitan, entre otras:

- Aumento del astigmatismo
- Error refractivo
- Infección intraocular
- Perdida de visión
- Problemas de winking
- Catarata subcapsular anterior
- Inflamación intracáular grave
- Glaucoma secundario
- Uveítis
- Vitritis
- Hipofosfía
- Corrección insuficiente/excesiva
- Pupila no reactiva
- Desprendimiento de retina
- Endofthalmitis
- IAS (Síndrome trófico del segmento anterior)
- Desprendimiento de retina
- Iritis
- Edema macular quístico
- Edema macular
- Descompensación corneal
- Edema corneal
- Ritmo pupilar
- Captivo del iris
- PIO > 5 mmHg por encima del valor basal y PIO > 25 mmHg

375 x 250 mm

